リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月15日（日）

第64号　朝刊

きょうの紙面　▶骨折 × 診療報酬　▶脳卒中 × 歩行　▶嚥下 × 肺炎　▶短信 8本

■ 骨折 × 診療報酬

骨折の二次予防に報酬 処方は倍増、病院差は拡大

京都大・DPC 168病院7.6万人　地方・民間・手術の少ない病院で効果小さく

京都大学の研究グループが、2022年4月に新設された二次性骨折予防継続管理料の前後で、大腿骨近位部骨折の手術を受けた50歳以上の入院中の骨粗鬆症薬の処方を、質改善事業に参加する168病院のDPCデータで比べた。対象は2020年4月～2024年3月の7万6,111人で、Osteoporosis Internationalに11月14日に載った。

管理料を算定した143病院では、処方の割合が30.9%から71.8%に増えた。算定しなかった25病院は20.7%から19.6%とほぼ横ばいだった。ところが病院間のばらつきを示すMORは2.66から3.39に広がり、同じ約2割から出発した病院が40.8%と83.9%に分かれた。効果は地方、民間、手術件数の少ない病院で小さかった。

前後比較の観察研究で因果は言えず、参加病院の偏りもあり、再骨折そのものは見ていない。著者らは一律の報酬だけでなく、人手の足りない病院を支える策が要るとする。転院してきた患者で骨粗鬆症の治療が始まっているかを確かめ、回復期で途切れさせないことが、二次予防の続きになる。



報酬は同じでも、届き方は病院ごとに違う。

出典 Osteoporosis International ↗

数字で見る

7.6万人
168病院の手術例

30.9→71.8%
算定病院の処方割合

2.66→3.39
病院間の差（MOR）

■ 脳卒中 × 歩行

左右で速さを変えるトレッドミルに差なし

入院リハ中の発症中央値13日の30人を、麻痺側のベルトを半分の速さにする練習と、左右同じ速さの練習に分けた。1回30分を1日2回、3週間続けた。Berg Balance Scaleは両群とも約18点上がったが、群間差は1.20点（95%信頼区間−5.30～7.71）だった。

歩行速度やADLも補正後に差は残らなかった。



評価できたのは26人で、差を見つける力は足りない。実施率は99.7%、有害事象はなかった。装置より歩く練習の量を考える材料になる。

出典 Medicine ↗

■ 嚥下 × 肺炎

顎で押す嚥下訓練 続けられたのは半数

75歳以上の市中肺炎の患者に、顎の下のボールを押しつぶす嚥下訓練（CTAR）を、アプリの即時フィードバック付きで12週続ける試験。声をかけた75人のうち24人が参加し、21人を通常ケア、1日1回、1日2回に分けた。最後まで続いたのは11人で、脱落は体調悪化や再入院が多かった。

EAT-10などの質問票は改善傾向、経口摂取の段階は変わらず、顎を引く力は平均0.8kgf増えた。効果の検証ではなく、本格的な試験に進めるかを見る段階だ。



出典 JMIR Formative Research ↗

短信

〈心臓リハ〉心筋の傷が大きいほど心リハが効く
中部労災病院のPCI後535人。外来心リハの参加でMACEが少なく、CPKが高い群で差が明瞭。後ろ向き研究。
出典 Future Cardiol ↗

〈医療AI〉AIのカルテ要約、精度を保つ
米国の心不全入院でAIが問題別に要約。医師の回答精度は88.0%対86.4%で、よく使う医師ほど速かった。
出典 JAMIA ↗

〈サルコペニア〉肝移植後にVR運動で筋力向上
肝移植後サルコペニア60人のRCT。通常の理学療法にVR運動を足すと、6週後の握力差9.55kg。 出典 PubMed ↗

〈評価〉PROMISの適応型検査は実用的
オランダの外来理学療法14施設。短い適応型の質問票は好評だが、得点の読み方に不安が残った。 出典 PubMed ↗

〈外傷〉高齢外傷の85%が6か月で自立
パキスタンの60歳以上288人。6か月でFIMの修正自立以上が85%、女性は活動参加の回復が遅かった。 出典 PubMed ↗

〈メンタル〉対話AIは人の支援併用が優位か
うつ・不安の41研究7,577人の統合。人の支援を強めた型が優位に見えたが、確実性は非常に低い。 出典 JMIR ↗

〈心不全〉フレイルを扱う試験は10件
心不全の介入試験でフレイルを層別や調整に使った研究は10件で、7件は事後解析。運動介入は2件だけ。 出典 PubMed ↗

〈手外科〉中手骨骨折の保存療法は根拠不足
34研究2,857人のスコーピングレビュー。固定の方法や期間がばらつき、受傷6週以降の治療の根拠が乏しい。
出典 PubMed ↗